CIRUGÍA VASCULAR - ENFERMEDADES VENOSAS

DR. ADRIÁN RUJANO

TROMBOSIS VENOSA MESENTÉRICA

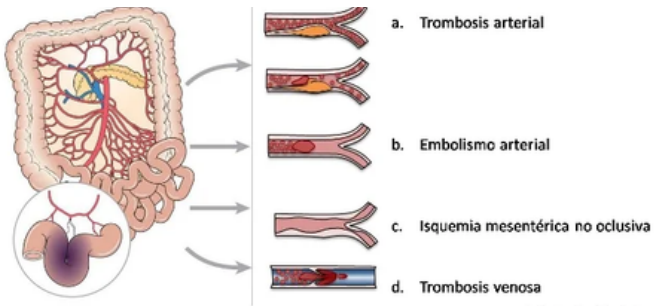
- Oclusión trombotica de la vena mesentérica superior o inferior; produce edema transmural, congestión e isquemia pasiva de las asas intestinales.
- Se asocia a hipercoagulabilidad, pancreatitis, diverticulitis o hipertensión portal; dolor abdominal insidioso, desproporcionado al examen físico.

TRATAMIENTO DE LA TROMBOSIS VENOSA

- A diferencia de la isquemia arterial (que requiere revascularización), el pilar es la anticoagulación sistémica precoz y prolongada: previene la propagación del trombo y favorece la recanalización.
- La laparotomía se reserva exclusivamente ante necrosis intestinal o peritonitis evidentes.

ISQUEMIA MESENTÉRICA ARTERIAL AGUDA

- Embolia de la arteria mesentérica superior (origen cardíaco, fibrilación auricular): dolor abdominal súbito y severo; requiere embolectomía o revascularización urgente.
- Trombosis arterial sobre placa aterosclerotica preexistente: inicio más insidioso, con angina intestinal previa.



HIPERTENSIÓN PORTAL Y VÁRICES ESOFÁGICAS

- Aumento de la resistencia vascular intrahepática (cirrosis) + vasodilatación esplácnica hiperdinámica → hipertensión portal (gradiente ≥10mmHg) → colaterales portosistémicas → várices esofágicas con riesgo de rotura y hemorragia masiva.

PROFILAXIS PRIMARIA DE SANGRADO VARICEAL

- Indicada en várices medianas/grandes, pequeñas con puntos rojos, o Child-Pugh C.
- Betabloqueadores no selectivos (carvedilol, propranolol, nadolol): meta de FC 55-60lpm o reducción del 25% de la FC basal.
- Ligadura endoscópica con bandas (LEB): de elección si hay contraindicación o intolerancia a betabloqueadores.

DERIVACIONES PORTOSISTÉMICAS

- TIPS (derivación intrahepática transyugular): sangrado variceal refractario o ascitis refractaria; riesgo principal: encefalopatía hepática.
- Derivación esplenorrenal distal: alternativa cuando el TIPS no está disponible o falla.

